

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫН БОЛЖАУДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ РӨЛІ

*Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.Қ., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ*

Жұмыстың мақсаты: сүт безі рагын (СБР) оның морфологиялық құрылысымен байланыстыра отырып, оған болжам жасау жолдарында пайдалану.

СБР – өте қауіпті қатерлі ісіктің біріне жатады. Себебі ол негізінен бөгелме ісік (БІ) беру арқылы науқасты тез арада өлімге душар етеді.

СБР неше түрлі клиникалық ағымда кездеседі; оның кейбір түрі, кейде өте баяу өсіп, көпке дейін БІ бермейді, ал көпшілігінде тез арада өршіп, БІ ерте пайда болып асқынады, ал кейбіреулері арнайы емге төзімді болып ісік тез арада өршиді. Осы көріністерді СБР-дың морфологиялық түрлерінен анықтауға және де оның алдын-ала болжам жасауға мүмкіншілік береді.

Зерттеудің негізгі шартты мәселелері:

СБР-дың морфологиялық түрлерінің жиілігін анықтау,

Олардың өмірге қауіпті түрлерін ажырата білу,

Морфологиялық түріне байланысты бөгелме ісіктің пайда болу жиілігін және олардың морфологиялық құрылысына байланыстылығын көрсету.

Жалпы СБРмен ауғандардың өмір сүру болжамындағы морфологиялық өзгерістердің рөлін сараптау,

Тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне дәйекті ұсыныс жасау.

Жұмыстың мақсатына жету және осы сұрақтарға жауап алу үшін СБР дәлелденген және емделуге келген 250 науқас тесерілген, бұлардың бәрі 30-60 жас аралығындағы әйелдер. Аурулардың барлығы морфологиялық жолмен зерттеліп, оның құрылысы анықталған (биопсия немесе хирургиялық операция арқылы) және олардың барлығына бірдей клиникалық тексеру әдістері қолданған.

Сонымен 250 СБР-дің, 225 ($90,0 \pm 2,0\%$) науқасына жайылмалы-инвазивті, ал 25-інде ($10,0 \pm 2,3\%$) жайылмалы емес рак анықталған. СБР - 41 науқаста ($16,4 \pm 2,3\%$) сүт безінің

сүт жолдарынан, 109 жағдайда ($83,6 \pm 2,3\%$) сүт өндірілетін бөлімдерінен пайда болған.

Пісіп жетілуіне сәйкес рак клеткалары жоғарғы деңгейде өніп өскені - 40 ($16,0 \pm 2,3\%$) әйелде, орташа деңгейдегісі - 70 ($28,9 \pm 2,8\%$) науқаста, ал ең төменгі деңгейдегісі - 140 ($56,0 \pm 3,0\%$) ауруда анықталған.

СБР-дың морфологиялық түрлері сан алуан: безді - 37 ($14,8 \pm 2,2\%$), солидты - 88 ($35,2 \pm 3,0\%$), скirrosды - 43 ($17,2 \pm 2,3\%$), солидты-скirrosды 57 ($22,8 \pm 2,6\%$), сүт өзегінен шыққан шашақты - 14 ($5,60 \pm 1,5\%$), медуллярлы - 4 ($1,6 \pm 0,7\%$) және жылауықты (кистозды) - 7 ($2,8 \pm 1,0\%$) түрлері дәлелденген. БІ болуы және олардың жиілігі тікелей СБР-дың морфологиялық құрылысына байланыстылығы анықталған. СБР-дың жайылмалы түрі 75,0% жағдайда, ал жайылмалы емес түрі - 25,0% БІ берген. Осыған байланысты аурулардың бес жылдық өмір сүру мерзімі де өзгерген - СБР-дың жайылмалы түріндегі аурулардың 24-26,0% ғана орташа есеппен емнен кейін бес жыл өмір сүрген, ал жайылмалы емес түрінде бұл көрсеткіш 3-4 есе жақсарған.

Сонымен СБР-дың морфологиялық түрлері көп және олар неше түрлі жиілікте кездеседі. Оның сүт өндіретін бөлімдері ($83,6\%$), сүт жолдарына ($16,4\%$) қарағанда жиі жарақаттанады. СБР-дың басым көпшілігі жайылмалы ($90,0\%$), ал сирек кездесетін түрі жайылмалы емес емес ($10,0\%$) рак. БІ беру жиілігі тікелей морфологиялық құрылысқа байланысты - бірінші орында скirrosды рак, ол 70-79,0% ауруларда, ал ісіктің таза безді түрі 32,4% жағдайда БІ береді. Тек қана морфологиялық түрлермен болжам тоқталып қалмайды, ісік клеткасының пісіп жетілуіне де тікелей клиникалық ағымға әсерін тигізеді. Рак клеткасы 16,0% жағдайда жоғары деңгейде пісіп жетіледі. де ол 30,0%, ал пісіп жетілмеген рак ($56,0\%$) - 80,0% жағдайда БІ пайда болады, сондықтан оның бұл түрі өте қауіпті болып саналады.

ПРИМЕНЕНИЕ МАБТЕРЫ ПРИ ЛИМФОМАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

*Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Джазылтаева А.С., Сагиндыков Г.А., Насипов Б.А.
РГП на ПХВ Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы.*

Лимфомы желудочно-кишечного тракта является наиболее частым вариантом экстранодальных лимфом. Среди всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта НХЛ желудочно-кишечного тракта составляют около 10%. Прогноз благоприятный и в основном зависит от локализации процесса: 10-летняя выживаемость превышает 50% при поражении желудка (51%), тонкого кишечника (54%), толстого кишечника (35%). Чаще лимфома ЖКТ встречается у взрослых (средний возраст заболевших 61 год), несколько чаще у женщин (проф. Волкова М.А. 2007).

В работе приведены предварительные результаты лечения 6 больных с экстранодальным вариантом НХЛ желудочно-кишечного тракта, из них с поражением желудка - 3, тонкого кишечника - 2, толстого кишечника - 1 пациент с множественными метастазами в печень.

Критерии включения: Состояние пациента в момент осмотра, размеры опухолевого узла, данные рентгеномногографических исследований, КТ и МРТ.

Критерии исключения: у пациентов выявлена гиперчувствительность к мабтере, возраст пациента свыше 70-80 лет, декомпенсация сердечной деятельности III-IV степени, печеночно-почечная недостаточность.

В группе наблюдаемых, было женщины-1, мужчины-5. У

пациентов с НХЛ желудка была проведена гастрэктомия, спленэктомия с лимфодиссекцией. У пациентов с поражением тонкого кишечника была проведена резекция тонкого и толстого кишечника с наложением анастомоза. Гистологически у всех больных была установлена диффузная крупноклеточная лимфома, иммуногистохимическое исследование показало присутствие во всех случаях CD 20+ антигена.

В условиях отделения гемобластозов всем пациентам было проведено 6-8 курсов химиотерапии по протоколу R-CHOP 21 в стандартных дозировках. У 5 пациентов отмечалась частичная регрессия процесса, полная регрессия процесса - 1 пациент. У 1 пациентки с НХЛ толстого кишечника с множественными метастазами в печень зарегистрировано частичная регрессия процесса. Состояние пациентов после лечения удовлетворительное, качество жизни по шкале Карновского составляет 3 бала. Отмечались эпизоды тромбоцитопении и лейкопении, которые были купированы введением колониестимулирующих факторов, переливанием тромбоконцентрата.

Таким образом, применение МаБтеры у больных с НХЛ желудочно-кишечного тракта показало хороший результат в виде частичной регрессии (70%) периферических лимфатических узлов и забрюшинного пространства и метастазов в печени.